LE SECOURISME



Document sur le secourisme

SOMMAIRE

DEFINITION ET CONDUITE A TENIR 03

DETRESSE CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIRE.....06

LES HEMORRAGIES.....08

DEGAGEMENT, DE RAMASSAGE ET DE BRANCARDAGE 10

LE SQUELETTE ET SES ATTEINTE 15

LES BRULURES.....17

LES BANDAGES 19

Section 1 : DEFINITION ET CONDUITE A TENIR

Définition

Le secourisme est une science et une technique qui se fait par des gestes répétés. Il est un état d'esprit, de prévention, une technique opérationnelle parfaitement maitrisée et sans cesse perfectionnée.

Etre secouriste

Etre secouriste, c'est savoir porter secours efficacement. C'est un rôle primordial, limité et temporaire.

- Rôle primordial : le secourisme est le premier maillon pour sauver une personne.
- Rôle limité : le rôle du secourisme se limite dès l'arrivée des secours spécialisés, son action s'arrête quand le spécialiste intervient.
- Rôle temporaire : selon l'urgence se dire que le temps nous est compté.

L'accident : C'est un événement brutal, imprévu qui entraine des dégâts. Pour qu'il y'est accident il faut un homme, moyen, défaillance, un danger.

Type d'accident : noyade, accident de circulation, accident domestique,

CONDUITE À TENIR

a) EVALUATION GENERALE

Le secouriste présent sur les lieux de l'accident agit en gardant son sang-froid, il évalue rapidement la situation sans précipitation. S'il y'a des témoins c'est lui qui prend l'initiative en se faisant aidé. Ainsi, il peut agir efficacement et empêcher les gestes néfastes des témoins bien intentionnés mais incompétents.

b) Les différents temps du secourisme

PROTEGER

C'est tout d'abord assuré la sécurité du secouriste, de la victime, des témoins, et des biens de la victime. Ainsi, il fait tout pour ne pas aggraver l'état de la victime. Quand cela est possible il supprime immédiatement et de façon permanente les dangers environnants pour protéger son action, la victime et les autres personnes du sur-accident.

- Baliser : le secouriste présent sur les lieux balise de part et d'autre de l'accident à 150m le jour et 200m la nuit avec des triangles de signalisation, lampe torche, linge agité par une personne, les feux de détresses. Interdire toute approche si le danger persiste. Couper le contacte des voitures accidentés si possible, ne pas fumer, ne pas laisser fumer. Dégager les victimes s'il y'a risque de sur-accident.

Les techniques de dégagements sont :

- Dégagement par les chevilles
- Dégagement par les poignés
- Dégagement par les aisselles
- La cuillère à trois
- Le dégagement d'un chauffeur au volant de sa voiture

ALERTER

Une fois la protection faite le secouriste doit alerter. L'alerte consiste à informer un service d'urgence de la présence d'une ou plusieurs victimes affecté par une ou plusieurs détresses. La rapidité d'intervention des secours d'urgence améliore le pronostic vital. Diminue les risques de séquelle, réduit la durée de l'hospitalisation.

- **QUI ALERTER?**

En ville la police sapeur-pompier 18, police secoure 17, SAMU national 15 15, SAMU municipal 88 828 12 13

En campagne alerté la gendarmerie 800 00 20 20 ou les autorités administratives

- **COMMENT ALERTER?**

En criant au secours

En téléphonant

En envoyant un message.

Le message de l'alerte doit être clair, précis, et préciser :

- Se présenter du secouriste et le numéro de téléphone utilisé
- La nature de l'accident
- Le lieu précis de l'accident
- Le nombre de victime et leur état apparent

N.B : ne jamais raccrocher sans autorisation

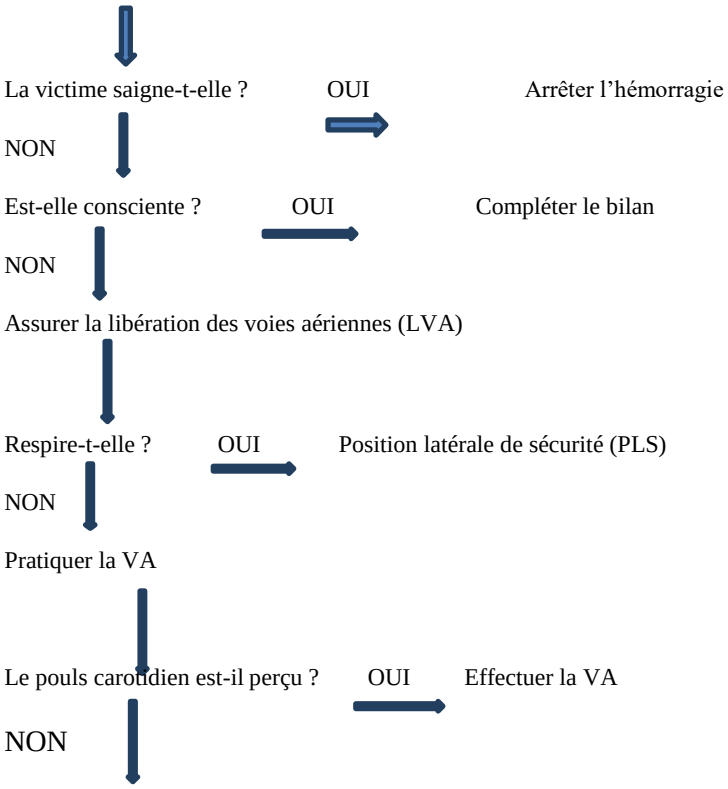
c) SECOURIR : Examen ou bilan

Le secours est un geste élémentaire de survie qui permet de sauver. Ce geste dépend de la nature de l'accident.

NB : le bilan de la victime se fait avant l'alerte pour expliqué l'état de la victime au secoure

<u>Le bilan d'une victime</u>

Après avoir protégé



Effectuer la réanimation cardio pulmonaire (RMC) et/ou le MCE

Ensuite surveiller la victime jusqu'à l'arrivés des secours.

Les positions de sécurités

Le secouriste une fois qu'il est terminé les premiers soins il met la victime dans une position d'attente et de sécurité. Les blessés qui ont perdu connaissances par exemple évanouissement on les met en position latérale de sécurité.

N.B : les femmes enceintes, les personnes obèses qui ont un gros ventre ont les couches sur le côté gauche. Les qui étouffe ou qui ont des difficultés respiratoires (asthme traumatisme du thorax) ont les met en position demi-assise. Blesser dans l'abdomen la victime est couché jambe fléchi. Blesser au niveau de colonne vertébrale ou du bassin la victime est couché sur le dos ou en débicutus dorsale.

Section 2 : DETRESSE CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIR

DETRESSE CIRCULATOIRE

Définition

La fonction circulatoire est l'une des 3 fonctions vitales, elle assure le transport des nutriments et de l'oxygène dans l'organisme. La détresse circulatoire résulte d'un trouble de ce transport qui provoque une déficience de l'oxygénation du cerveau.

Les causes

Les causes des arrêts circulatoires sont nombreuses et peuvent se rattacher :

- CŒUR : maladie cardiaque, rétrécissement des artères coroners, mal formation du cœur
- Au vaisseau sanguin : rupture du vaisseau sanguin, rétrécissement du vaisseau sanguin
- Le sang et le plasma : diminution du volume sanguin en cas d'hémorragie ou du plasma en cas de brulure de troisième degré, cela crée un choc hypovolémique ou état de choc.

Les signes

Le sujet fait de la sueur, il est pale, ses extrémités sont refroidis (pied, main), il à froid son pouls est rapide et filant parfois même imprenable au niveau du poignet, sa tension chute, il est angoissé, il somnole parfois même il perd connaissance.

POUR DETRESSE CIRCULATOIRE.

- Mettre la victime en position du choqué
- La couvrir
- Et l'évacuer en extrême urgence à l'hôpital
- En cas d'arrêt cardiaque faire la ventilation artificielle et le M.C.E (massage cardiaque externe)

.

DETRESSE RESPIRATOIRE

Définition

On parle de détresse respiratoire quand il y a disfonctionnement de l'appareil respiratoire pouvant entraîner un trouble de l'organisme.

La détresse respiratoire se caractérise par une insuffisance, une accélération ou une absence (arrêt) momentané ou total de la respiration.

Les causes

Les causes de détresse respiratoire sont multiples :

- L'air n'arrive plus aux poumons, il y a obstacle dans les voies respiratoires. Exemple (eau pour le noyé), terre ou sable (écroulement), neige (avalanche), sac plastique dans lequel un enfant met sa tête, drap ou oreiller mou obstruant le visage d'un bébé, perle, pièce de monnaie, bille, bouton dans la trachée artère.
- Corde, écharpe, foulard, cravate serrée autour du cou, pendaison ou prise dans un moteur ou une croix de transmission.
- Chute de la langue en arrière chez un inconscient.
- Paralysie des muscles respiratoires (hémorragie dans le cerveau).
- Coup sur la tête, à la nuque ou bien à la gorge.

- Absorption d'alcool en quantité excessive
- Intoxication par certain gaz
- Maladie comme la poliomyélite, le tétanos, l'asthme etc.
- Parfois l'air ne contient pas assez d'oxygène (atmosphère polluée).
- Long séjour dans de l'eau froide.

Les signes

- Absence de mouvement respiratoire ou augmentation (accélération).
- Battement des ailes du nez.
- Tirage intercostals.
- Affaissement de l'entonnoir xiphoïdien
- Changement anormal du visage, des lèvres et des ongles.
- Le pouls est filant, il fait la somnolence, peut même perdre connaissance.

Conduite à tenir (C.A.T)

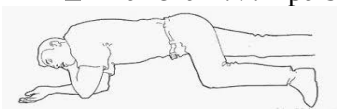
1er cas : corps étranger dans les voies respiratoires.

- Faire une manœuvre de désobstruction (manœuvre de Heimlich).



2e cas : la victime est en perte de connaissance mais respire et le cœur bat.

- Faire la L.V.A puis la P.L.S



3e cas : victime inconsciente et qui ne respire pas.

- Faire une L.V.A et V.A

4e cas : victime inconsciente qui ne respire pas et son cœur ne bat pas.

- Faire une L.V.A, V.A et M.C.E

Pour un arrêt cardio respiratoire :

- Faire la L.V.A puis le M.C.E



Section 3 : LES HEMORRAGIES

L'hémorragie c'est un saignement ou un écoulement non contrôlé du sang en dehors de son circuit naturel (vaisseaux, cœur).

CAUSES

L'hémorragie peut être causée par des maladies cardio vasculaire, l'hyper-tension artérielle, fibrome, maladie des poumons (tuberculose) maladie digestive (Ébola), par un objet tranchant ou pointu (couteau, lame…), arme à feu, choc (coup sur la tête, au niveau du cou, du nez, oubien par l'arrachement d'un organe, par décélération.

CONSEQUENCE D'UNE HEMORRAGIE

Une hémorragie est dite importante lorsque le saignement peut imbiber un mouchoir de tissu ou de papier en quelques secondes. Le risque de décès est de court terme.

Suivant la quantité de sang perdu et la localisation du saignement une hémorragie entraine :

- Une perte de globule rouge anémie
- Une baisse de la pression artérielle
- Une compression d'organes vitaux pouvant entrainer une mort rapide

<u>Types d'hémorragies</u>

Nous distinguons 3 types d'hémorragies

- L'hémorragie externe
- L'hémorragie interne
- L'hémorragie extériorisée
- **L'hémorragie externe**

C'est l'écoulement du sang à travers le corps par une ouverture de la peau (plaie)

Conduite à tenir (C.A.T)

Après constat de l'hémorragie se protéger les mains avec des gangs ou un sac en plastique ou utiliser un pansement individuel et comprimé directement à l'endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main quelques soit le lieu du saignement. Cette technique est appelé « compression manuel local », si elle est efficace on fait un pansement compressif. Si le pansement compressif n'arrête pas totalement l'hémorragie il sera complété par la pause d'un deuxième pansement compressif au-dessus du premier pour augmenter la compression.

Si l'hémorragie ne s'arrête pas faire le point de compression à distance.

Le point de compression à distance : c'est un endroit privilégié du corps ou on peut plaquer l'artère sur un plan osseux, exemple au niveau de la carotide (carotidien), au niveau de la sous clavaire (sous clavaire), au niveau de l'huméral (huméral), au niveau du pli de laine (inguinal) et la fémorale (fémoral).

Allonger la victime en position horizontal et sur élever la partie du corps atteint cela va faciliter la circulation sanguine au niveau du cerveau.

Le garrot

Le garrot est une arme dangereuse que le secouriste doit poser en cas de membre incarcéré (membres sous charge), en cas de plaie sèche ou si le secouriste est seul en face de plusieurs victimes.

On pose le garrot entre la plaie et le cœur. Pour les membres supérieurs au niveau du bras, membres inférieurs au niveau de la cuisse. Une fois le garrot posé, on prend l'heure de la pose sur une étiquette et on évacue la victime en première urgence.

Ne jamais couvrir la partie qui supporte le garrot.

- **L'hémorragie interne**

C'est quand il y'a écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins mais à l'intérieur du corps

Les causes

Choc au niveau de l'abdomen, au niveau du cou au niveau du dos ou accident de véhicule par décélération (arrachement d'organes internes, foie, rate, rein).

Les signes : voir détresse circulatoire

Conduite à tenir (C.A.T)

Rassurer la victime, l'allonger, soulever les membres inférieurs pendant 30s à 1mn, la ramener à 20cm du sol pour les maintenir en position du choqué. Si la victime est inconsciente on le met en position latérale de sécurité. Tout en soulevant les membres inférieurs on ne donne ni à boire, ni en manger, l'envelopper pour la maintenir au chaud et l'évacuer en extrême urgence.

- **L'hémorragie extériorisée**

C'est l'écoulement du sang par un orifice naturel. Les cas suivants peuvent se présenter

Saignement de l'oreille, Saignement du nez, Vomissement de sang, Crachement de sang, Présence de sang dans les urines, Présence de sang dans les selles

SAIGNEMENT DE L'OREILLE C.A.T

Poser une compresse sur l'oreille qui saigne, faire coucher la victime sur le côté qui saigne et l'évacuer dans cette position à une structure de sanitaire.

SAIGNEMENT DU NEZ C.A.T

Faire asseoir la victime tête penchée en avant, dégrafé la chemise, faire comprimée à la victime la narine qui saigne et l'évacuer dans un structure sanitaire.

N.B : toutes personnes ayant reçu un choc violant à la tête et saigne du nez ou de l'oreille et parfois même accompagnée d'une perte d'eau claire qui doit être considéré comme un fracture de la boite crânienne.

VOMISSEMENT DE SANG C.A.T

Mettre la victime au calme et en gaité, recueillir les vomissures dans un récipient et amené la victime et la vomissure au poste de santé.

CRACHEMENT DE SANG C.A.T

Mettre la victime dans une position demi-assise, donner ni à boire ni à manger et l'évacuer dans un poste de santé.

: évité les accidents d'exposition au sang en portant des équipements de protection individuel.

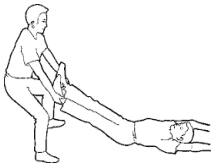
DEGAGEMENT

Dégager la victime sans se rendre compte de ses blessures pour éviter un sur accident.

Exemple : accident sur l'autoroute, immeuble qui tombe,...

Techniques de dégagement d'urgence

- **Traction par les chevilles** : dégager la victime en tirant par les chevilles. Cette méthode peut se faire à 2, le second tient la tête.



- **Traction par les poignets :** dégager la victime en tirant par les poignets.



- **Traction sous les aisselles :** dégager la victime en tirant sous les aisselles.

- **Croisées des mains** : croiser les mains autour du thorax et plaquer la victime contre sa poitrine, soulever et dégager.



- **Dégagement en cas de fuite de gaz** : ramper pour aller vers la victime. Le secouriste lie les 2 mains de la victime, mettre la tête entre les mains liées puis ramper vers la sortie en soulevant la tête.

Victime coincée accessible d'un seul côté.

- **Méthode cuillère simple ou cuillère à 3**.

Nécessite 3 secouristes dont un chef.

D'abord enlever les objets comme montres, bagues…

Présentation des mains.

Le chef commande :

 Secouristes en position pour la méthode cuillère simple.

Les secouristes se mettent à genou

Le 1er secouriste présente ses mains sur la victime, mi-jambe mi-cuisse.

Le 2e secouriste, mi-jambe mi- bassin.

Le 3e secouriste, thorax tête.

Le chef commande

- Attention pour engager.
- Engager (on engage sans soulever).

On baisse la tête vers la victime.

On met le coude à terre.

Le chef commande

- Prêt

Secouristes

- Prêts
- Soulevez et mettez sur le genou.
- Plaquez
- Attention pour lever, levez
- Joignez les pieds

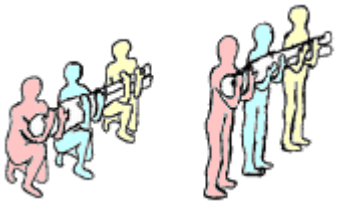
S'il y a un obstacle devant

On recule de 2 pas au commandement à chaque fois que l'obstacle est présent.

- Pivotez
- Avancez

Pour poser

- Halte
- Genou à terre
- Rabattez
- Envoyez et posez



RAMASSAGE

Ce sont les méthodes utilisées pour soulever et installer une victime sur un brancard.

Nous avons les méthodes ou le brancard va vers le blessé et les méthodes ou le blessé va vers le brancard. Ces méthodes se décomposent en 2 temps : **levez** et **posez**

Méthode ou le brancard va vers le blessé :

- **Méthode cuillère 2+1**

Nécessite 3 secouristes.

Cette méthode est utilisée pour poser une victime sur un brancard.

Même commandement que la méthode cuillère simple.

Au moment de lever, le secouriste qui est au milieu laisse le bassin en faisant avancer les 2 autres secouristes qui continuent de plaquer.

Celui-ci va chercher le brancard puis il se met à genou face aux 2 secouristes et tient le bassin.

Puis le chef commande :

- Rabattez
- Envoyez
- Posez

- **<u>Méthode pont simple</u>**

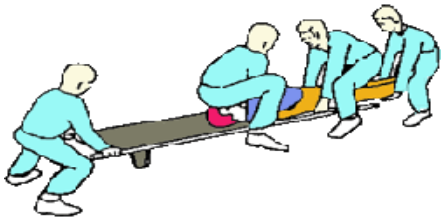
Cette méthode nécessite 4 secouristes, les 3 secouristes sont en pont sur la victime et le 4eme glisse le brancard.

Presentation des mains

- Engagez
- Soulevez

Le chef prend le brancard et le glisse entre les jambes des secouristes.

- Posez



- **<u>Pont amélioré</u>**

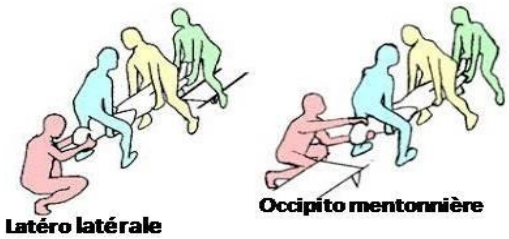
Cette méthode est utilisée pour une victime polie fracturée. Elle nécessite 5 secouristes.

Même commandement que le pont simple. Le 5e secouriste s'occupe uniquement de la tête.

Pour tenir la tête il y a :

La méthode occipito mentonnière : on tient la tête et le menton.

La méthode latéro latérale : tenir les 2 côtés de la tête.



<u>Méthode ou le blessé va vers le brancard</u>

- **<u>Pont néerlandais</u>**

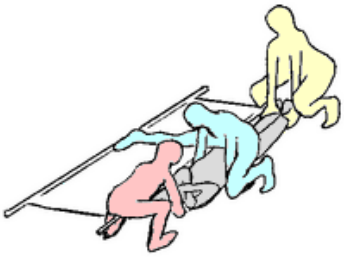
Pour 3 secouristes

Les 2 secouristes bloquent le poignet du brancard avec un des pieds, l'autre pied se met en position latérale de la victime.

Le chef s'appuie sur les 2 secouristes pour se mettre en position un des pieds sur le brancard.

Le chef commande:

- Presentation des mains
- Engagez
- Soulevez
- Posez



Pour sortir, c'est le chef qui sort le 1er en s'appuyant sur les 2 secouristes.

Pour 4 secouristes : cette méthode est utilisée pour une victime polie fracturée. Même commandement que le pont néerlandais, le 4e secouriste tient la tête en position occipito mentonnière ou latéro latérale.

BRANCARDAGE

C'est une technique utilisée pour transporter une victime à l'hôpital. Il se fait avec un brancard.

Composition d'un brancard

Le brancard est un instrument sur lequel on fait coucher une victime pour le transporter à l'hôpital.

- 4 poignets
- 2 hampes de 2,25cm
- 4 pieds fixes ou amovibles
- 2 traverses ou compos
- 2 manettes ou boutons de sécurité
- Une toile sur laquelle se repose la victime
- Un appui têtière
- 2 sangles ou ceintures de sécurité.

Les techniques de brancardage

Le brancardage comporte 2 méthodes : **bout de bras** et **épaulement.**

- **Brancardage à 4 à bras tendus**

Cette méthode nécessite 4 secouristes dont le chef qui est toujours à derrière à droite.^

Sangler d'abord la victime.

Le chef commande :

- Secouristes en position pour le brancardage à 4 à bout de bras.
- En position
- Attention pour lever
- Lever
- Devant vous marchez avec le pied droit derrière avec le pied gauche.
- Attention pour avancer
- Avancer

Pour poser

- Attention pour poser
- Poser

- **Brancardage à 2**

Si l'équipe compte 2 secouristes, un secouriste devant et l'autre secouriste se met derrière. Même commandement que le brancardage à 4 à bras tendus.

- **Brancardage à 2+1**

Un devant et 2 derrière, si l'équipe compte 3 secouristes.

- **Brancardage à 5**

4 secouristes plus le chef qui commande et surveille la victime.

- **Brancardage avec épaulement**

Le chef commande :

- Secouristes en position pour le brancardage avec épaulement
- Attention pour lever
- Lever
- Attention pour épauler
- Epauler

Pour poser

- Décharger
- Poser

NB : on transporte le blessé sur un brancard la tête en avant, cela permet de surveiller le blessé. Exceptionnellement, on peut mettre les pieds en avant en cas de perfusion ou de ventilation artificielle (V.A).

Le brancard doit rester en position horizontale, le pas des secouristes doit être doux et synchronisé, la couverture doit être en position diagonale. Le blessé doit être sanglé.

TRANSPORT IMPROVISE

- Saisie à 4 mains
- Saisie à 3 mains
- Saisie à 2 mains
- Méthode sur chaise
- Béquilles

Section 5 : LE SQUELETTE ET SES ATTEINTES

I. LES FRACTURES

On dit fracture quand il y a cassure complète ou incomplète d'un os.



1. TYPES DE FRACTURE

- Une fracture est dite fermée lorsqu'il y a cassure de l'os sans ouverture de la peau
- Une fracture est dite ouverte ou évidente lorsqu'elle est accompagnée d'une perforation de la peau

2. SIGNES ET SYMPTOMES

- Déformation, enflamment, ouverture de la peau, gonflement, douleur sensible, incapacité de mouvementé la partie fracturée, raccourcissement passible du membre, passibilité de craquement entendue par la victime et le sauveteur.

3. CAUSES

- Des chocs directs, ex : personne heurtée par un véhicule
- Les chocs indirects ; ex : chute.
- Des exercises physiques
- Des fausses manœuvre, ex : torsion du pied ou main

4. CONSEQUENCES

- Paralysie en cas de fracture de la colonne vertébrale
- Hémorragie en cas de fracture ouverte
- Épanchement de sang en cas de fracture de cote (poumon)
- Raideur articulaire en cas de fracture au niveau des articulations

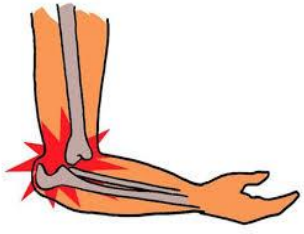
5. CAT DEVANT UNE FRACTURE

- Fracture du crâne, de la colonne vertébrale et du bassin : immobiliser sur un plan dure ou matelas Coquil
- Fracture des cotes : faire un bandage de corps peu serré et mettre en position demi-assise
- Fracture de la clavicule ou de l'omoplate : écharpe oblique
- Fracture du bras (humérus) écharpe et contre écharpe
- Fracture de l'avant-bras : immobilisé avec deux atèles plus écharpe simple
- Fracture du coude : écharpe de Mayor
- Luxation de l'épaule : écharpe oblique avec billot
- Fracture du fémur (cuisse) : immobilisé avec deux atèles : un atèle interne qui va du pied jusqu'au pli des ailes
- Un atèle externe qui va du pied jusqu'au creux de l'aisselle
- Fracture de la jambe : immobilisé avec deux atèles de même dimension qui vont du pied jusqu'à la mi-cuisse.

II. LUXATION

1. DEFINITION

Il y'a luxation lorsque suite à un étirement ligamentaire la tête d'un os sort de sa cavité ou boite articulaire.



III. ANTORSE

a. DEFINITION

Ce sont des lésions articulaires causé par un étirement ligamentaire sans déplacement osseux. Les parties les plus touché sont les genoux et les chevilles.

b. SIGNES ET SYMPTOMES

Enflure et douleur de l'articulation touchée, Incapacité fonctionnel de la partie touchée

c. C.A.T

- Installé confortablement la victime
- Appliquer des bains froids si possibles afin de réduire l'enflure et atténuer la douleur
- Ne pas retirer la chaussure, elle sert d'attelle et empêche l'enflure
- Immobiliser avant de déplacer la victime.

Section 6 : LES BRULURES

Définition

C'est une atteinte de la peau provoquée par la chaleur.

Les causes

- Feu, Electricité, Soleil, Produits chimiques, Frottements

Certains animaux peuvent causer une brulure (méduse).

Gravité d'une brulure

La gravité d'une brulure dépend de l'étendue, de la profondeur, du siège (partie brulée), de l'âge de la victime, de l'antécédent, des risques d'infection, le danger de mort est proportionnel à la surface brulée.

Les types de brulures

Nous distinguons 3 types de brulures

1. **Brulure de 1er degré**

Il s'agit d'une rougeur de la peau, elle est provoqué en générale par le frottement ou le coup de soleil.



Conduite à tenir (C.A.T)

Nettoyer la partie atteinte avec de l'eau et du savon et appliquer de la poudre talc.

2. **Brulure de 2e degré**

Il s'agit d'apparitions sur la partie brulée de cloques, de grosseurs variables remplies de liquide claire.

La brulure du 2e degré intermédiaire est une destruction de l'épiderme provoquée par une source de chaleur.



Conduite à tenir (C.A.T)

- Arroser à l'eau courante la partie atteinte.
- Retirer bague ou montre avant que la partie brulée ne commence à s'enfler.
- Si les cloques ne sont pas percées, faire des soins avec un mercurochrome ou un antiseptique.
- Prendre garde de ne pas percer les cloques.

S'il s'agit d'une brulure de 2e degré intermédiaire :

- Recouvrir entièrement la plaie brulée avec des compresses stériles ou un linge propre et évacuer à l'hôpital.

3. **Brulure de 3e degré**

Il s'agit d'une brulure qui dépasse la peau et qui atteint les muscles, les mains, les vaisseaux sanguins et parfois même les os.



Conduite à tenir (C.A.T)

- Utiliser la méthode des trois E : Envelopper, Etiqueter, Evacuer vers la structure sanitaire le plus proche

Si les vêtements ou les cheveux d'une personne sont en feu :

Eteignez les flammes en les étouffant avec une couverture ou drap ou bien verser de l'eau pour éliminer la température et prenez toutes dispositions requises pour que la victime reçoive le plus rapidement possible des soins médicaux.

Conduite à tenir (C.A.T) **devant un brulé chimique**

- Arroser la victime en grande eau (faire prendre une douche à la victime).
- Enlever ses habits et l'évacuer en extrême urgence à l'hôpital.
  - **Huile en feu** :
- Couvrir la marmite (oxygène)
- L'enlever du feu ou du gaz (température)

- **Gaz en feu**

- Mouiller un linge et mettre sur le bec du gaz pour étouffer la température

Section 7: LES BANDAGE

Definition

C'est un morceau de tissu stérile qui sert à protéger ou à envelopper une partie du corps blessé et à maintenir un pansement.

- **Le bandage**

C'est l'action d'envelopper une plaie à l'aide d'une bande.

Technique

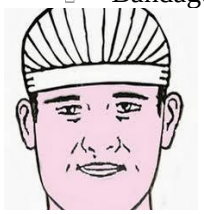
On commence tout bandage par deux tours circulaires, on rabat le billet entre le 1er et le second tour pour empêcher la bande de glisser. Sauf exception le secouriste tient la bande dans la main droite, globe en l'air et fait le bandage de la gauche vers la droite. Il termine le bandage par deux tours circulaires et fixe la bande avec une épingle de sureté pour les bandes Velpeau, un nœud plat pour les bandes de gaze.

Méthodes de bandage

- **Bandage du front ou du cuir chevelu**



- Bandage de la tête : Capeline



- Bandage des tempes : Croisée des tempes

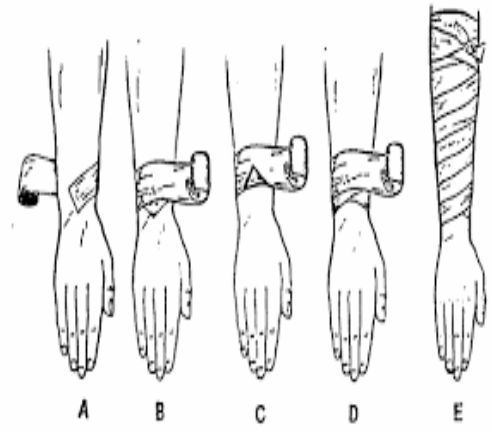
- Bandage d'un seul œil : Monocle



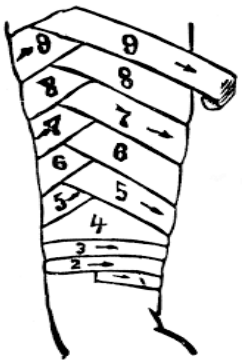
- Bandage des 2 yeux : Binocle



- Méthode spirale (normale)



- Méthode renversé (croisé)

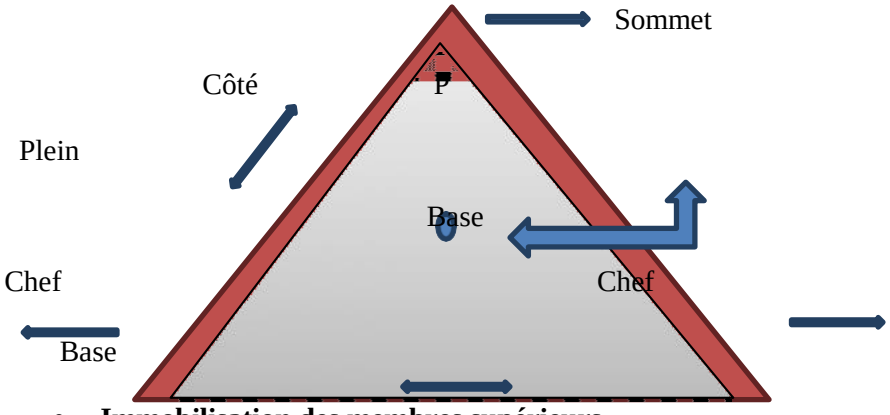


- Méthode spica du doigt



- **Echarpe**

L'écharpe sert à immobiliser et à transporter un blessé

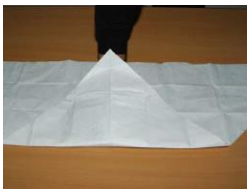


- **Immobilisation des membres supérieurs**

Sommet = coude

- **L'emballage triangulair**

Sert à protéger ou à emballer les parties du corps qui sont bossus (le front, la nuque, le coude, le genou), larges (abdomen, poitrine, hanche, épaule, jambe, main, avant-bras, pieds).






- **Mayor**

Luxation du coude

Sert à emballer les 2 coudes ensemble.

Attacher une écharpe à la taille ou ceinture, joindre une autre écharpe, attacher les 2 écharpes et emballer les 2 coudes.

- **Echarpe simple**

Fracture de l'avant-bras



- **Echarpe contre écharpe, immobilisation avec la chemise**

Fracture du bras



- **Echarpe oblique**

Déboitement de l'épaule, fracture de la clavicule.

- **Gouttière**

Méthode d'immobilisation avec un objet dur. On accroche le bras à l'aide d'une bande qui passe au cou.

- **Fronde**

Morceau de tissu fendu sur les 2 extrémités. Sert à emballer des parties du corps tels que le doigt, le menton.